Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Parotidectomie

Ablation partielle ou totale de la glande salivaire parotide (située devant l'oreille)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche

Étendue prévue : ☐ Superficielle ☐ Partielle / extracapsulaire ☐ Totale ☐ À décider pendant l'intervention _____

Monitorage du nerf facial : ☐ Sera utilisé ☐ Ne sera pas utilisé

Diagnostic préliminaire (résultat de la cytoponction / de l'imagerie) : _____

Décision convenue à l'avance si la tumeur envahit le nerf facial : ☐ Une branche nerveuse peut être sacrifiée ☐ Préserver le nerf ☐ Autre _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

La glande parotide est la plus grande des glandes salivaires. Il y en a une devant et juste en dessous de chaque oreille. Le **nerf facial**, qui fait bouger les muscles du visage, traverse la glande et s'y divise en plusieurs branches. La chirurgie de la parotide est donc une chirurgie délicate, au cours de laquelle on veille tout particulièrement à protéger ce nerf.

La parotidectomie est le plus souvent réalisée en raison d'une **grosseur (tumeur)** dans la glande. La grande majorité de ces grosseurs (environ 80 %) sont **bénignes (non cancéreuses)** ; les plus fréquentes sont l'adénome pléomorphe et la tumeur de Warthin. Une grosseur bénigne peut néanmoins grossir avec le temps, et certaines (en particulier l'adénome pléomorphe) peuvent devenir malignes au fil de nombreuses années. Moins souvent, l'intervention est nécessaire en raison d'infections à répétition, de calculs ou d'une tumeur maligne.

Le but de l'intervention est d'enlever complètement la grosseur ou le tissu glandulaire malade **tout en préservant le nerf facial**, et d'établir le diagnostic définitif par l'examen anatomopathologique.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Avant l'opération, la grosseur est évaluée par échographie, IRM et/ou cytoponction (ponction à l'aiguille fine) ; ces examens apportent des informations préliminaires utiles, mais le diagnostic définitif est posé par l'examen anatomopathologique après l'intervention.

1. **Incision :** L'incision commence généralement dans le pli naturel situé devant l'oreille, contourne le dessous du lobe de l'oreille et se prolonge dans un pli de la peau du cou. Dans les cas qui s'y prêtent, l'incision peut être plus courte ou dissimulée à la lisière des cheveux.
2. **Repérage du nerf facial :** La peau et les tissus recouvrant la glande sont soulevés et le tronc principal du nerf facial est repéré. S'il est utilisé, un appareil de **monitorage nerveux** aide à suivre la position et le fonctionnement du nerf tout au long de l'intervention.
3. **Ablation de la grosseur / de la glande :** Le nerf et ses branches sont suivis avec précaution pendant que la grosseur est retirée avec une marge de tissu glandulaire sain. Selon la position et la taille de la grosseur, seule la partie externe de la glande (superficielle), une partie de celle-ci ou la glande entière (totale) peut être retirée.
4. **Examen anatomopathologique :** Le tissu retiré est envoyé au laboratoire d'anatomopathologie. Le résultat définitif est généralement disponible dans un délai de 1 à 2 semaines.
5. **Fermeture :** Le saignement est contrôlé et un fin **drain** (tuyau) est généralement mis en place pour évacuer le sang ou le liquide qui pourrait s'accumuler. La peau est refermée par des points fins et un pansement légèrement compressif peut être appliqué.

Si la tumeur entoure le nerf facial ou s'est développée à l'intérieur de celui-ci (ce qui se produit surtout avec les tumeurs malignes), il peut être nécessaire de sacrifier une branche du nerf, ou le nerf entier, afin d'enlever complètement la tumeur. Cette éventualité est **discutée avec vous séparément** avant l'intervention. Le nerf ne sera pas sectionné de manière inattendue sans que cela ait été discuté avec vous ; la conduite à tenir si la tumeur ne peut pas être séparée du nerf est convenue avec vous à l'avance.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 2 à 4 heures	Généralement 1 à 2 nuits ; sortie après le retrait du drain

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Ablation de la grosseur et diagnostic définitif
- Éviter qu'une grosseur bénigne ne grossisse, ne comprime le nerf facial et, à long terme, ne devienne maligne
- Pour les tumeurs malignes, première et plus importante étape du traitement
- Fin des douleurs et des gonflements dus aux infections à répétition ou aux calculs

Pour la plupart des tumeurs bénignes, l'intervention permet une guérison définitive. Pour les adénomes pléomorphes retirés selon une technique appropriée, le taux de récidive est **inférieur à 1 à 2 patients sur 100** ; toutefois, une rupture de la capsule de la tumeur ou une intervention antérieure augmente ce taux. Une tumeur de Warthin peut apparaître sous la forme d'un nouveau foyer dans la même glande ou dans la glande opposée. Pour les tumeurs malignes, le résultat dépend du type et du stade de la tumeur, et un traitement complémentaire peut être nécessaire.

4 Autres options thérapeutiques

- **Surveillance :** Pour certaines petites grosseurs considérées comme bénignes (par exemple une tumeur de Warthin chez des patients âgés ou présentant un risque opératoire élevé), un suivi régulier par échographie/IRM peut être envisagé. La grosseur reste alors en place et peut grossir, et aucun diagnostic définitif ne peut être posé.
- **Traitement médical :** En cas d'infection ou de calculs : antibiotiques, boissons abondantes, massages ; dans les cas qui s'y prêtent, extraction des calculs par endoscopie des canaux salivaires (sialendoscopie). Le traitement médical n'est pas une option pour les tumeurs.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Radiothérapie :** Utilisée pour les tumeurs malignes qui ne peuvent pas être opérées, ou en complément de la chirurgie ; ce n'est pas le traitement privilégié des tumeurs bénignes.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Sans intervention, la grosseur reste en place et aucun diagnostic définitif ne peut être posé. Les tumeurs bénignes grossissent généralement lentement, mais avec le temps elles peuvent augmenter de volume, rendant l'intervention plus difficile et augmentant le risque pour le nerf facial ; les adénomes pléomorphes peuvent devenir malins au fil de nombreuses années (environ 5 à 10 % au fil des années). Une tumeur maligne non traitée progressera et pourra s'étendre aux tissus voisins et aux ganglions lymphatiques.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Avant l'intervention, des analyses de sang, une imagerie (échographie/IRM) et, si nécessaire, une cytoponction sont réalisées ; vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez ni manger ni boire pendant les **6 à 8 heures** précédant l'intervention (veuillez suivre les consignes du médecin anesthésiste).
- Chez les hommes, la barbe et les poils autour de l'oreille dans la zone d'incision peuvent être raccourcis le jour de l'intervention. Selon l'incision, quelques cheveux derrière l'oreille peuvent être égalisés.
- Les mouvements de votre visage sont examinés et photographiés avant l'intervention afin de consigner leur fonctionnement avant l'opération.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24 à 48 heures	Vous ressentirez une sensation de tiraillement, une douleur légère à modérée et un gonflement dans la zone opérée, soulagés par des antalgiques. Le drain est généralement retiré le 1er ou le 2e jour, lorsque le liquide diminue. Il est recommandé de dormir la tête surélevée. Les mouvements de votre visage seront contrôlés.
1re semaine	Après votre sortie, vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes. Les points sont généralement retirés **entre le 5e et le 7e jour**. Un engourdissement du lobe de l'oreille et de la zone située devant l'oreille est nettement perceptible. Le résultat de l'anatomopathologie est généralement disponible pendant cette période ou peu après, et il vous sera communiqué.
2e à 6e semaine	La plupart des personnes reprennent un travail de bureau en 1 à 2 semaines. Le sport intense et les travaux nécessitant de se pencher et de soulever des charges doivent être reportés d'environ **2 à 3 semaines**. En cas de faiblesse faciale temporaire, celle-ci commence

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	généralement à s'améliorer en quelques semaines ; une protection de l'œil et des exercices faciaux sont recommandés.
3e à 12e mois	La cicatrice s'estompe progressivement. L'engourdissement du lobe de l'oreille s'améliore en partie. La plupart des patients ayant présenté une faiblesse nerveuse temporaire récupèrent complètement en 6 à 12 mois. Une transpiration de la joue pendant les repas (syndrome de Frey), si elle survient, peut apparaître au cours de cette période.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Douleur, tiraillement et gonflement dans la zone opérée
- Engourdissement du lobe de l'oreille et de la peau située devant l'oreille
- Une cicatrice au niveau de l'incision (s'estompe avec le temps)
- Légère douleur du côté opéré à l'ouverture de la bouche ou à la mastication (premiers jours)

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Faiblesse temporaire du nerf facial** — Chez environ **10 à 40 patients sur 100** (selon la quantité de tissu retiré et l'emplacement de la grosseur), on observe une faiblesse temporaire au coin de la bouche, à la fermeture de l'œil ou pour lever le sourcil. Elle ne touche généralement qu'une seule branche et **s'améliore en quelques semaines à quelques mois**. Si votre œil ne se ferme pas complètement pendant cette période, vous devrez utiliser des gouttes, un gel et un pansement oculaire la nuit pour éviter la sécheresse de l'œil.
- **Diminution permanente de la sensibilité du lobe de l'oreille** — Le nerf qui assure la sensibilité du lobe de l'oreille (nerf grand auriculaire) est touché lors de la plupart des interventions. L'engourdissement diminue avec le temps chez la plupart des patients, mais une certaine diminution de la sensibilité du lobe de l'oreille et de la zone environnante peut être **permanente**. Cela n'affecte généralement pas la vie quotidienne.
- **Syndrome de Frey (transpiration pendant les repas)** — Transpiration et rougeur de la joue du côté opéré pendant les repas. Bien qu'il soit détecté plus souvent à l'aide de tests, il est perceptible chez environ **10 à 20 patients sur 100** et apparaît généralement plusieurs mois plus tard. S'il est gênant, il peut être traité par des crèmes antitranspirantes ou par des injections de **toxine botulique**.
- **Creux au niveau de la joue** — Selon la quantité de tissu retiré, un léger creux devant l'oreille et une différence entre les deux côtés peuvent apparaître. S'ils sont visibles, ils peuvent être corrigés par de la graisse ou un produit de comblement.

Situations peu fréquentes

- **Accumulation de liquide (sérome) ou de salive (sialocèle) / fistule salivaire** — Chez environ **5 à 10 patients sur 100**, du liquide ou de la salive peut s'accumuler dans la zone opérée ; rarement, il s'écoule à travers la peau (fistule). Cela se résorbe généralement en quelques semaines grâce à une ponction à l'aiguille, un pansement compressif et, si nécessaire, de la toxine botulique.
- **Saignement et hématome** — Chez environ **1 à 3 patients sur 100**, du sang peut s'accumuler sous la peau. S'il est important, il peut être nécessaire de l'évacuer et d'arrêter le saignement au bloc opératoire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Infection de la plaie** — Survient chez **1 à 3 patients sur 100** ; elle guérit généralement avec des antibiotiques et, rarement, un drainage est nécessaire.
- **Syndrome de la première bouchée** — Surtout après une intervention sur le lobe profond, douleur vive à l'angle de la mâchoire durant quelques secondes lors des premières bouchées d'un repas. Elle diminue généralement avec le temps.
- **Récidive de la grosseur** — Bien que peu fréquent pour les tumeurs bénignes, la grosseur peut réapparaître au même endroit, ou un nouveau foyer peut se développer dans le cas d'une tumeur de Warthin ; cela peut nécessiter une nouvelle intervention. Lors des réinterventions, le risque pour le nerf facial est plus élevé.
- **Cicatrice épaisse ou chéloïde** — Selon la prédisposition de chacun, la cicatrice peut s'épaissir ; des injections de corticoïdes ou d'autres traitements des cicatrices peuvent être utilisés.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Paralysie faciale permanente** — Pour les tumeurs bénignes opérées pour la première fois, environ **1 à 3 patients sur 100** peuvent garder une faiblesse permanente d'une branche du nerf facial ou, rarement, du nerf entier. Cela peut entraîner un affaissement du coin de la bouche, une fermeture incomplète de l'œil, un sourire asymétrique et une sécheresse oculaire ; si l'œil n'est pas protégé, une lésion de la surface transparente à l'avant de l'œil (cornée) et une perte de la vue peuvent survenir. Le risque est plus élevé en cas de tumeur maligne, de réintervention et de grosseur adhérente au nerf. Si une paralysie permanente s'installe, des traitements complémentaires tels que des médicaments protégeant l'œil, la pose d'un poids dans la paupière, une réparation nerveuse ou une chirurgie de réanimation faciale peuvent être nécessaires.
- **Résultat anatomopathologique définitif différent du diagnostic préliminaire** — Même si les examens préopératoires évoquent une grosseur bénigne, l'examen anatomopathologique définitif peut révéler une tumeur **maligne**. Dans ce cas, une intervention complémentaire (ablation du reste de la glande ou des ganglions lymphatiques du cou), une radiothérapie ou d'autres traitements peuvent être nécessaires.
- **Hématome important du cou affectant les voies respiratoires** — Très rarement, une accumulation de sang qui augmente rapidement peut comprimer le cou et provoquer des difficultés à avaler ou à respirer. Il s'agit d'une urgence : l'hématome doit être évacué immédiatement au bloc opératoire et, rarement, il peut être nécessaire de sécuriser les voies respiratoires (intubation ou trachéotomie).
- **Problèmes de vascularisation de la peau** — Désunion du bord de la plaie, en particulier sous le lobe de l'oreille, due à une diminution de l'irrigation sanguine de la peau ; plus fréquente chez les fumeurs.
- **Modification de la forme du lobe de l'oreille ou altération de la sensibilité du pavillon de l'oreille** — Rare ; due à l'incision ou à une atteinte nerveuse.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Gonflement du cou ou de la joue qui augmente rapidement**, surtout s'il s'accompagne de difficultés à avaler ou à respirer (urgence — appelez le 112)
- **Saignement qui ne s'arrête pas** au niveau du drain ou de la plaie
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur, douleur ou chaleur croissante, ou écoulement de pus au niveau de la plaie
- **Faiblesse nouvelle ou qui s'aggrave** des mouvements du visage
- Si vous ne pouvez pas fermer complètement l'œil : **rougeur, sensation de sable, douleur ou vision trouble** de l'œil
- **Écoulement de liquide clair** par la plaie, ou gonflement mou devant l'oreille qui ne cesse de grossir

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Gardez la plaie au sec pendant les 48 premières heures ; ensuite, vous pouvez prendre une courte douche tiède selon les consignes qui vous ont été données.
- Au cours des premières semaines, éviter les aliments très acides et ceux qui stimulent fortement la salivation peut réduire le risque d'accumulation de liquide.
- En cas de faiblesse du nerf facial, utilisez des larmes artificielles en gouttes pendant la journée, ainsi qu'un gel oculaire et un pansement oculaire la nuit ; protégez votre œil du vent et de la poussière.
- Protégez la cicatrice du soleil pendant au moins 6 mois (crème solaire à indice de protection élevé).
- Veillez à discuter du résultat anatomopathologique et du plan de suivi avec votre médecin ; des contrôles réguliers sont recommandés, même pour les tumeurs bénignes.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que la relation entre le nerf facial et la grosseur ne peut être vue avec certitude que pendant l'intervention, que le diagnostic définitif sera posé par l'examen anatomopathologique après l'intervention et qu'un traitement complémentaire pourra être nécessaire en fonction du résultat.
- ☐ Avant l'intervention, la conduite à tenir concernant le nerf dans le cas où la tumeur aurait envahi le nerf facial a été discutée avec moi, et ma décision a été consignée dans la rubrique des informations du patient.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.